P2-T2 第二次课上-part1

小美转入 ICU 后，胆道支架引出的胆汁让黄疸开始消退，可所有人的心却绷得更紧——她的血红蛋白还在一天天往下掉，血小板死死趴在 20×10^9/L 上纹丝不动，外周血涂片里满眼都是红细胞碎片。医生们心里那个沉重的猜想，必须用一管血来坐实。这管血被加急送往血液科实验室，几天后结果回来了：ADAMTS13 酶活性 <5%（正常参考 >67%），抑制物抗体阳性——确诊免疫性血栓性血小板减少性紫癜（iTTP）。补体系统检测未见活化。

诊断落了地，疑问却更深了：一个 22 岁的年轻孕妇，为什么会得上这种罕见的疾病？医生回到床边，把病史一个问题一个问题地重新核实。问到“这是第几次怀孕”时，小美别过头去，半晌才开口——这已经是她第三次怀孕，前两次分别在孕 7 周、孕 8 周时不明原因自然流产了。两次流产，一次比一次让人心碎。年轻的小美，到底怎么了？

1. iTTP 有哪些诱因？iTTP 的治疗原则？

2. 病人的情况如何与 HELLP 综合征鉴别？

3. 截止目前，该患者的病情及化验指标变化仍有哪些疑点？下一步患者还需要补充哪些检查？